

LINFANGITIS

Jésica Rodríguez Álvarez. Javier Sanchez Palacios. Joaquin Rodríguez Prieto. Asunción García Alonso, Maria Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una infección primaria local de los vasos linfáticos superficiales producida por la flora autóctona de la piel, sin afectación sistémica. Se produce típicamente por estreptococos del grupo A, aunque puede producirse por otros microorganismos.

Es la complicación más frecuente en pacientes con linfedema pudiendo llegar a afectar hasta a un 40% de los mismos.

Clasificación:

- **Primaria:** Puede denominarse linfangitis o erisipela, diferenciándose ésta última de la anterior en que puede ser contagiosa y que tiene afectación/ reacción sistémica.
- **Secundaria** o dermatolinfangioadenitis: afectación de la hipodermis y tejido celular subcutáneo por la flora microbiana ambiente. Alta tendencia a la recurrencia.

DIAGNÓSTICO

Clínico

Dolor, aumento del edema y eritema de inicio rápido, en cuestión de horas. Suele tener un factor desencadenante previo como puede ser un traumatismo o una picadura. Si se acompaña de vesículas, linforragia, fiebre o vómitos lo catalogaríamos de grave.

Se debe hacer un diagnóstico diferencial con tromboflebitis superficial y TVP, dermatitis de contacto, micosis y eczema venoso.

Pruebas Complementarias

- Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria. Bioquímica básica y coagulación. Importante valorar VSG, PCR, PCT y leucocitosis.

TRATAMIENTO

- Reposo y elevación del miembro afecto.
- Retirar prenda de compresión durante el episodio. Volver a colocar una vez el episodio cese.
- Evitar autodrenaje o drenaje linfático.

Penicilina G Benzatina 1.200.000 im, en dosis única que se pondrá de forma

+

1ª elección: Amoxicilina-Clavulánico 875/125mg cada 8 horas durante 15 días.

2ª elección: Cloxacilina 500mg cada 6 horas durante 15 días.

En alérgicos a penicilina:

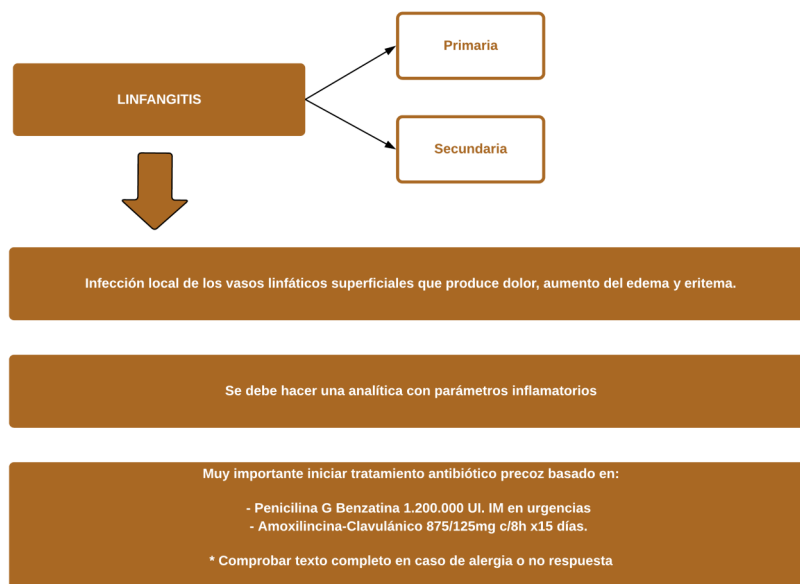
1ª elección: Eritromicina 500mg c/8h o Claritromicina 500mg c/12h 15 días.

2ª elección: Ciprofloxacino 750mg c/12 horas durante 10 días.

Si tras 48 horas no se produce mejoría y vuelve a acudir a urgencias: Cefazolina 1g c/8h iv.

- Tratamiento antibiótico precoz basado en:
- Se pueden asociar paracetamol para el dolor. Los AINES **no están recomendados** por riesgo de fascitis necrotizante.

- Derivar al servicio de Rehabilitación de forma preferente.
- Se debe valorar el ingreso hospitalario en casos de: sospecha de septicemia, signos de afectación sistémica persistentes tras 48h de tratamiento o persistencia de los signos locales a pesar del uso de la primera y segunda línea de tratamiento.



BIBLIOGRAFÍA

- Olszewski WL. Infection. in: lee BB, Bergan J, Rockson SG, editors. Lymphedema: a concise compendium of theory and practice. London: Springer Verlag London limited; 2011. p. 207-216.
- Guía de práctica clínica. Orientación diagnóstica y terapéutica del Linfedema. Puigdemívol Serafí C. (coord) y Alonso Álvarez B. (coord). 2017: 39-44.
- UK dermatology clinical trials network's patch trial team, Thomas K, Crook A, Foster K, Mason J, Chalmers J, et al. Prophylactic antibiotics for the prevention of cellulitis (erysipelas) of the leg: results of the UK dermatology clinical trials network's PATCH II trial. Br J dermatol. 2012;166(1):169-78.